

19 - 02- Trouble Anxiété Généralisée (TAG) - Pr. LAFFINTI

(0:01 - 0:50)

Chers étudiants, nous allons continuer notre série de cours par un deuxième trouble anxieux appelé le trouble anxiété généralisé. Le trouble anxiété généralisé se caractérise par un état de tension anxieuse qui est permanente et par une appréhension par des préoccupations et des soucis excessifs qui vont concerner différents événements ou situations de la vie quotidienne. Ces soucis, cet état d'anxiété va se prolonger sur une durée de deux à six mois et plus.

(0:51 - 1:47)

Il s'agit d'une pathologie qui peut être très gênante et qui altère le fonctionnement habituel du sujet et peut être très handicapante en termes de qualité de vie. Il s'agit d'un motif fréquent de consultation en médecine générale, souvent pour des symptômes d'ordre physique, ce qui fait que c'est une pathologie aussi qui consomme énormément le système du soin du fait de la multiplication des consultations auprès des médecins avant de pouvoir poser le diagnostic de trouble anxiété généralisé. L'évolution du trouble se fait sur plusieurs années et c'est un trouble dont les comorbidités sont très importantes, notamment en termes de dépression.

(1:52 - 2:22)

Sur le plan épidémiologique, c'est un trouble comme pour la plupart des troubles anxieux touchent plus les femmes que les hommes, 6% des femmes et 3% des hommes en population générale. L'enquête réalisée au Maroc en 2003 trouve un taux de prévalence de 9,3%. L'âge de début est plus retardé par rapport au trouble panique.

(2:23 - 2:55)

C'est surtout une pathologie de l'adulte, avec un pic vers l'âge de 35 ans pour les femmes et vers l'âge de 45 ans pour les hommes. Elle est considérée comme le trouble anxieux le plus fréquent chez les sujets âgés. Les comorbidités sont fréquentes, comme on vient de citer, notamment avec la dépression, et certains facteurs sont considérés comme des facteurs de risque, notamment les situations de veuvage, de divorce, de veuvage et le chômage ou les séparations.

(3:00 - 3:22)

Sur le plan clinique, le trouble anxiété généralisée est caractérisé par une anxiété et par des soucis excessifs. Ce sont les deux principales composantes de la clinique du trouble anxiété généralisée, donc un fond d'anxiété et des soucis et des préoccupations qui sont excessifs. D'abord, ces soucis.

(3:23 - 3:54)

Les soucis du trouble anxiété généralisée sont proches ou sont identiques aux préoccupations que chacun de nous ou des inquiétudes que tout le monde peut avoir dans sa vie quotidienne. Il se distingue des soucis considérés comme étant normaux par leur permanence. Ils sont présents pratiquement toute la journée et pratiquement tous les jours pendant une durée très prolongée.

(3:55 - 4:16)

C'est la durée de six mois qui est retenue pour poser le diagnostic du trouble anxiété généralisée. Et c'est aussi des soucis qui sont incontrôlables, que le sujet n'arrive pas à contrôler. Donc, ils vont envahir son esprit et ils vont tourner en sorte de monologue interne sans fin.

(4:18 - 4:51)

Ce sont des soucis que la personne n'arrive pas à gérer ou à stopper. Ces soucis, ils sont maintenus et entretenus ou renforcés par une certaine intolérance à l'incertitude qui est présente chez ces patients présentant un trouble anxiété généralisée. Donc, les soucis sont considérés pour des soucis pour tout et pour rien.

(4:51 - 5:19)

Donc, pour tout, parce que toute situation de la vie quotidienne peut constituer un véritable problème, un véritable souci pour le patient et même pour les situations les plus banales. Donc, les soucis peuvent concerner plusieurs domaines de la vie. Donc, généralement, ça concerne trois ou plus plusieurs domaines de la vie.

(5:19 - 5:34)

Ça peut être le travail. Donc, le sujet va avoir des soucis non justifiés de perdre son travail, d'être licencié. Ça peut concerner la santé, soit du patient lui-même ou de sa famille.

(5:34 - 5:59)

Donc, les soucis d'attraper une maladie, d'avoir des blessures, d'être atteint d'une pathologie grave. Ça peut concerner la famille. Donc, les sujets craignent qu'un membre de leur famille ait un accident ou soit victime d'un enlèvement, d'un viol.

(5:59 - 6:22)

Et ce sont des soucis qui ne sont pas fondés et ne sont pas justifiés. Donc, ça peut aussi être, ça peut concerner tout problème divers. Le fait d'arriver en retard à un rendez-vous peut constituer chez ces patients un énorme problème.

(6:23 - 6:59)

Le fait de rater un bus ou rater une émission en télé peut justement constituer un véritable

problème chez ces patients. À côté de ces préoccupations qui sont excessives, il y a aussi un fond d'anxiété. Une anxiété qui est envahissante, qui est omniprésente, qui est toujours là, quasiment tout le temps.

(7:00 - 7:24)

Donc, elle est qualifiée de floue parce qu'elle n'est pas en rapport avec quelque chose de bien précise. Aussi, elle est qualifiée de flottante parce qu'elle est superficielle, capable de se fixer sur n'importe quel événement ou sur n'importe quelle situation de la vie quotidienne. Cette anxiété est présente dès le matin, dès le réveil.

(7:24 - 8:01)

Elle va culminer le soir ou avec des ruminations anxieuses, des préoccupations qui vont s'accroître le soir. L'anxiété va se traduire sur les trois registres classiques psychique, physique et comportemental. Sur le plan psychique, cette anxiété va se manifester par un état de tension interne permanent et pénible qui va entraîner une souffrance significative chez ces patients.

(8:01 - 8:43)

Les patients vont se sentir d'être à bout, d'être survoltés. Donc, ils sont en une sorte d'un état de kélivre et d'alerte permanent avec une hyper vigilance vis-à-vis de l'environnement, une intolérance vis-à-vis de l'environnement. Il va s'associer, bien sûr, à un sentiment d'insécurité, un sentiment d'une attente anxieuse, une menace qui n'est pas précise, ce qui va se traduire, bien sûr, par une irritabilité.

(8:44 - 9:32)

Donc, le sujet est complètement irritable, facilement, il se porte facilement avec son entourage, avec sa famille. Et tout ça va s'accompagner, bien sûr, par des troubles cognitifs, notamment des troubles de concentration et de troubles de mémoire. Sur le plan physique, ce qui est décrit le plus, c'est une tension musculaire qui est quasiment tout le temps présente et qui est en rapport avec son sentiment de malaise permanent.

(9:33 - 10:06)

Donc, le sujet est tout le temps tendu, ses muscles sont tendus, ce qui explique la multiplication des plaintes comme des cervicalgies, des céphalées. Donc, c'est un motif très fréquent de consultation, les céphalées. Des douleurs rachidiennes, mais aussi une hyperactivité neurovégétative qui va se manifester par des palpitations, par des sueurs, par des bouffées de chaleur, par une instabilité tensionnelle, par des vertiges.

(10:08 - 10:43)

Ce sont les mêmes signes cliniques de l'anxiété qu'on a vu dans le trouble, dans l'attaque de panique. Mais là, ils sont atténués et moins intenses. Sur le plan physique, l'asymptomatique se traduit aussi par des troubles du sommeil, notamment à l'endormissement, une insomnie d'endormissement qui va s'accroître par ces réminiscences anxieuses qui vont s'accroître le soir, mais aussi par des réveils au milieu de la nuit.

(10:44 - 11:24)

Le sommeil du patient est souvent agité, non réparateur et de mauvaise qualité. Tout ça va amener un sentiment de fatigabilité qui est ressenti par les patients. Sur le plan comportemental, l'asymptomatologie de cet état de tension et de malaise va se traduire par une fébrilité intérieure, parfois même une agitation importante, mais c'est moins le cas par rapport à une véritable attaque de panique.

(11:24 - 12:02)

C'est surtout cette fébrilité intérieure, cette instabilité qui peut se voir chez ces patients. Sur le plan comportemental aussi, en réaction à cet état d'hypervigilance, d'alerte permanente, on peut voir des réactions de sursaut au moindre stimulus, au claquement des portes, à un klaxon ou juste au contact physique. Le patient va sursauter parce qu'il est toujours dans cet état de menace et d'appréhension permanente.

(12:04 - 12:45)

Toujours sur le plan comportemental, chez ces patients, on décrit une certaine procrastination, une tendance à ne pas terminer les tâches ou à reporter ce qui doit être fait en raison d'une certaine indécision. On croit ou doute à l'indécision et l'incertitude et ceci va amener à une certaine procrastination. Concernant le diagnostic du trouble d'anxiété généralisée, le diagnostic positif est essentiellement clinique.

(12:45 - 13:37)

Il se base sur la présence d'un fond d'anxiété et des soucis qui sont excessifs et incontrôlables sur une durée de plus de six mois, qui sont associés à plus de trois autres symptômes, notamment l'irritabilité, la tension musculaire, l'agitation, la fatigabilité, le sentiment d'être survolté, les troubles du sommeil. Et qui vont entraîner une souffrance et une altération du fonctionnement du sujet. Et il faut que ce trouble ne soit pas imputable, ni à une substance psychoactive, ni à une maladie organique, ni expliquée par notre trouble mental.

(13:43 - 14:17)

Concernant le diagnostic différentiel du trouble d'anxiété généralisée, il se fait premièrement avec l'anxiété qui peut être considérée comme normale, notamment chez certains patients aux

tempéraments anxieux, avec une tendance non pathologique aux inquiétudes. Mais là, les soucis restent contrôlables. Elles restent limitées dans le temps de courte durée et sans retentissement majeur sur la qualité de vie des sujets.

(14:20 - 14:57)

Et ce fait également avec le trouble de l'adaptation. L'adaptation correspond en fait à un trouble où il y a des symptômes émotionnels tels que la tristesse ou l'anxiété, mais qui sont en lien avec une situation ou un événement stressant bien identifié. Et cette réaction d'anxiété ou son niveau d'anxiété peut disparaître une fois la situation ou l'événement déstabilisant passé.

(14:58 - 15:29)

Et ça reste limité dans le temps. Ce fait également avec le trouble panique qu'on vient de voir, donc où il y a la récurrence des attaques de panique avec des symptômes intercritiques, mais ils ne sont pas en lien avec des soucis de la vie quotidienne. Le trouble obsessionnel compulsif, les inquiétudes et les idées obsédantes sont plus.

(15:30 - 16:18)

Ils ont plus un caractère plutôt absurde et vont pas se limiter au thème de la vie quotidienne, mais peuvent intéresser d'autres thèmes plus. Plus vastes comme les soucis, les thèmes de doute, de la symétrie des microbes, etc. Dans la dépression, la symptomatologie anxieuse ou l'état d'anxiété qui accompagne la dépression entre le cadre du tableau global du syndrome dépressif et avec les symptômes essentiels de la dépression, telle la tristesse, l'anédonie, le ralentissement psychomoteur.

(16:19 - 16:32)

Quand on parle d'anxiété ou d'anxiété, on parle de l'anxiété, l'anxiété, le stress, etc. Une maladie qui peut être très fréquente et qui peut être Donc, on peut avoir les deux à la fois. C'est une maladie très fréquente.

(16:33 - 17:04)

50% des cas. Le trouble somatisation, qui est aussi un diagnostic différentiel. Donc les préoccupations sont limitées à des soucis de santé, donc ils ne vont pas être limités à un seul domaine qui est des préoccupations de santé, contrairement aux troubles d'anxiété généralisée, où ces préoccupations et ces soucis concernent au moins deux, trois domaines au plus de la vie quotidienne.

(17:06 - 17:52)

Le diagnostic différentiel se fait aussi avec l'anxiété induite qui est liée ou qui est secondaire à

une affection organique telle l'hypertéroidie, le phéochromocytome, l'hypoglycémie, etc. Cette anxiété peut aussi être induite dans certains cas par une intoxication ou un abus de substance. Et dans ce cas, on ne peut pas retenir le diagnostic de trouble d'anxiété généralisée quand l'anxiété et l'état anxieux est en lien avec une pathologie organique ou elle est secondaire à l'utilisation d'une substance ou d'un médicament qui induit cette anxiété.

(17:57 - 18:28)

Sur le plan étiopathogénique, comme pour la plupart des pathologies psychiatriques, l'origine multifactorielle est avancée. Donc, il existerait des facteurs génétiques qui ne seraient que communs. Sur le plan neurobiologique, il existe certaines hypothèses, celles du dysfonctionnement de la neurotransmission neuroadrénergique et serotoninergique.

(18:30 - 19:32)

Une autre hypothèse est celle du système GABA qui est un système inhibiteur du système nerveux central et qui semble le plus impliqué dans le cadre du trouble d'anxiété généralisée. Pour cette hypothèse, on suppose qu'il existerait une élévation du taux du diazepam benzine inhibiteur qui est un inhibiteur de la liaison du diazepam à ses récepteurs, ses récepteurs benzodiazepiniques qui sont couplés aux récepteurs du système GABA et qui permettent l'activation de ce système. Donc, l'activation de ce DBI, donc ce inhibiteur de la liaison du diazepam, va entraîner un dysfonctionnement du système GABA et qui joue un rôle de système inhibiteur.

(19:39 - 20:46)

Des facteurs psychologiques et environnementaux sont également avancés, notamment certains tempéraments innés qui sont caractérisés par des troubles de l'attachement, par une mauvaise, une moins bonne gestion des émotions, un moins bon contrôle des frustrations et qui seraient des tempéraments et des terrains favorables au développement du trouble d'anxiété généralisée. Certains événements de vie, comme un environnement familial qui n'est pas équilibré ou une relation mère-enfant qui est perturbée, sont également avancés dans la genèse du trouble. Le modèle cognitif, quant à lui, suggère qu'il existerait des schémas cognitifs dysfonctionnels chez ces patients avec des croyances erronées, notamment une perception, une interprétation de l'environnement comme étant potentiellement dangereux.

(20:47 - 21:35)

Existerait aussi chez ces patients une surestimation de la probabilité de survenue des événements négatifs, donc avec une anticipation péjorative de l'avenir. Existe aussi, comme on l'a vu un peu plus haut, une intolérance à l'incertitude, et puisqu'on ne peut jamais être certain du futur, ça renforce ce sentiment d'anxiété et cette appréhension qui est permanente. Le trouble d'anxiété généralisée s'installe insidieusement et évolue de façon chronique sur plusieurs

années.

(21:35 - 22:03)

On en a plus de dix ans. C'est une évolution qui est fluctuante, marquée par des périodes d'aggravation de la symptomatologie, dont des moments de stress. Les complications essentielles sont représentées par des comorbidités psychiatriques, notamment la dépression, qui se voit dans plus de 50% des cas et qui renforce le risque suicidaire.

(22:03 - 23:00)

Il existe aussi un retentissement socioprofessionnel important, qui va se traduire par des arrêts de travail répétés, mais aussi par une relation familiale perturbée, avec des difficultés chez les proches qui sont harcelées par ces appréhensions du sujet et qui n'ont pas de réponse pour le sujet. Et bien sûr, ils ont du mal à tolérer et à gérer l'anxiété du patient, d'où une jeune fonctionnelle importante. Et on termine par le chapitre du traitement, qui consiste en trois volets, d'abord des mesures générales, des traitements psychothérapeutiques et un traitement pharmacologique.

(23:07 - 23:37)

Les mesures générales, même si elles sont souvent méconnues, mais elles sont indispensables. Donc, elles consistent en l'éducation du patient concernant sa pathologie, avec une information adaptée sur les symptômes, sur leur origine psychique, sur l'évolution du trouble, les aggravations périodiques et sur les possibilités du traitement. Ces mesures consistent aussi en des règles hygiéno-diététiques qu'il faut adapter.

(23:37 - 23:56)

Ce sont des règles simples, mais elles ne sont pas toujours faciles à faire respecter aux patients. Il faut une alimentation équilibrée, une activité régulière. Il faut aménager l'emploi du temps et laisser des périodes de repos.

(23:56 - 24:15)

Il faut un sommeil de bonne qualité, de durée suffisante. Il faut prévoir des plages de loisirs, de distraction. Et aussi, il faut éliminer tout ce qui est excitant, toxique, comme le tabac, l'alcool, la caféine, etc.

(24:17 - 25:01)

Ces mesures permettent de réduire l'intensité et l'importance des symptômes. C'est aussi des mesures, des exercices de relaxation et de respiration pour conseiller aux patients des exercices simples, des tutoriels, des vidéos à suivre pour des exercices de relaxation, de gestion de stress

ou du yoga, par exemple. Deuxièmement, le traitement psychothérapeutique consiste en plusieurs psychothérapies.

(25:01 - 26:04)

Une psychothérapie de soutien, tout d'abord, que tout médecin peut pratiquer et qui consiste en une écoute simple et empathique du patient. On va essayer d'écouter ses souhaits et l'inciter à parler de ses préoccupations avec des conseils simples donnés aux patients. Les thérapies comportementales et cognitives ont donné des résultats très positifs, que ce soit à court ou à long terme, c'est des thérapies bien codifiées qui sont réalisées par des gens spécialisés à cet effet, qui se font sur une douzaine ou 25 séances en fonction des cas, qui consistent en une approche cognitive qui va tenter d'identifier les pensées irrationnelles et essayer de les faire changer et les remplacer par des pensées plus adaptées.

(26:05 - 26:55)

L'approche comportementale va essayer de réduire cette hyperactivité végétative par des techniques plus spécifiques de relaxation et aussi d'exposition et de désensibilisation. Pour le traitement pharmacologique, on dispose de plusieurs types de médicaments. Premièrement, les benzodiazépines qui ont un effet anxiolytique rapide et quasi constant, mais ceux-là vont être à l'origine d'une certaine automédication avec un risque de dépendance et de sévère.

(26:56 - 27:49)

Leur utilisation doit être limitée et réservée aux phases d'accentuation des manifestations anxieuses. Puisque dans le TAG, dans le trouble d'anxiété généralisée, la durée est un peu plus longue que celle pour le trouble de panique, donc on préfère des molécules à demi-vie plus longues comme l'alprazolam, le Lexomil, donc un demi à un comprimé par jour réparti en deux à trois prises et on va essayer de faire une dégression rapide pour l'arrêter au bout de un ou jusqu'à deux mois. Pour les antidépresseurs, donc les antidépresseurs sont considérés comme le traitement de fond du trouble d'anxiété généralisée.

(27:49 - 28:33)

Donc certaines molécules ont là et même dans ce trouble, comme la paroxétine, comme l'inhibiteur sélectif de la recapture de sérotonine ou des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et l'anadrénaline comme l'avenlafaxine et la duloxétine, la duloxétine à la posologie de 30 milligrammes. Leur délai d'action est de quatre à six semaines, bien sûr qu'il faut toujours expliquer. Donc l'instauration se fait toujours de façon progressive, on commence par des petites doses comme pour tous les troubles anxieux et l'arrêt à la fin du traitement se fait également de façon progressive.

(28:34 - 29:39)

La durée totale du traitement est de minimum six mois, mais la plupart du temps, on a besoin de plus de temps pour le traitement, notamment en cas de rechute. Le traitement antidépresseur dans le cadre du trouble d'anxiété généralisée est d'autant plus justifié en cas de dépression associée qui supporte en plus de 50% de dégâts. À côté des benzodiazépines et des antidépresseurs, d'autres médicaments peuvent être intéressants comme la buspirone, qui est un anxiolytique non benzodiazépinique qui n'a pas cet effet de dépendance ni d'effet hypnotique, mais dont les résultats ne sont pas très satisfaisants et qui n'est pas commercialisé au Maroc.

(29:40 - 30:12)

L'hydroxyzine, la TARAX ou TARAX-725, est une molécule intéressante comme alternative aux benzodiazépines qui est un antihistaminique qui a des effets anxiolytiques, certes, et qui peut être prescrit sans risque de dépendance. Donc, si on a besoin d'un traitement de longue durée, on peut avoir recours à l'hydroxyzine. Le seul inconvénient est une sédation plus marquée et qui peut se prolonger même pendant la journée.

(30:16 - 30:48)

Donc, en conclusion, le TAG reste un trouble qui est fréquent, qui est chronique et qui va altérer, bien sûr, la qualité de vie et le fonctionnement du sujet. Il peut être considéré comme une véritable maladie des inquiétudes. Donc, sa reconnaissance et sa prise en charge précoce vont améliorer, bien sûr, la qualité de vie et vont prévenir les complications, d'où l'intérêt du rôle du médecin généraliste dans la reconnaissance et aussi dans la prise en charge.

(30:49 - 30:49)

Merci.